

基金项目：江苏省卫生健康经济管理研究课题“基于内部控制视角的公立医院科研经费包干制落地研究”（CW202611）

作者简介：吴慧（南通大学附属医院，会计师）

通信作者：施小如（南通大学附属医院，高级会计师）E-mail:1072326992@qq.com

公立医院科研经费包干制的内控逻辑与路径

英文题名：Internal Control Logic and Pathways for Implementing the Lump-Sum

System of Research Funding in Public Hospitals

作者：吴慧，施小如*，张煦利（南通大学附属医院，江苏 南通 226001）

作者英文信息：WU Hui, SHI Xiaoru*, ZHANG Xuli (Affiliated Hospital of Nantong University, Nantong 226001, Jiangsu, China)

中图分类号：R197.322；G311 文献标识码：A

摘要

目的 从内部控制视角梳理公立医院科研经费包干制研究进展，识别已有研究的共识、分歧与空白。方法 以 24 份资料为综述基础，其中 15 篇中文学术文献纳入“全生命周期×COSO 五要素”矩阵编码。结果 现有研究主要集中在执行环节的控制活动与信息化嵌入，对申报前端和成果转化后端讨论不足；文献已就放控并行、负面清单、分级授权和嵌入式监管形成较明确共识，但在过程管理与放权边界的衔接、授权阈值设置、绩效与内控指标耦合等方面仍缺少可操作方案。结论 包干制落地的关键不是单纯减少审批，而是由医院在放权后重新设计内部控制，把负面清单、分级授权和信息系统规则转化为可执行的管理工具。

关键词：公立医院；科研经费包干制；内部控制；负面清单；全生命周期管理

Abstract

Objective This review examines research on the lump-sum funding system in public-hospital research from an internal-control perspective, identifying consensus, disagreements and gaps, and deriving hospital-level implementation pathways. **Methods** Drawing on 24 materials as the review base, 15 Chinese academic articles were entered into a "full lifecycle × COSO five components" matrix for comparative coding. **Results** Existing studies concentrate on control activities and IT embedding at the execution stage, while front-end application intervention and back-end achievement transformation receive insufficient attention. Consensus has formed on parallel decentralization-and-control, negative-list management, tiered authorization and IT-embedded supervision; operational solutions remain inadequate for process-management compatibility, authorization thresholds and the coupling of performance assessment with internal-control indicators. Four research gaps are identified: hospital-level implementation schemes, concrete "negative list + tiered authorization" tools, measurement of cognitive divergence across research / management / finance roles, and evidence chains for small-sample institutional settings. **Conclusion** The key to implementing the lump-sum system lies not in reducing approvals, but in redesigning internal control after decentralization, with negative lists, tiered authorization and embedded systems serving as actionable meso-level tools.

Keywords: public hospitals; research-funding lump-sum system; internal control; negative list; full-lifecycle management.

1 引言

近年来，我国科研经费管理改革持续向纵深推进。2019 年，政府工作报告首次提出开展项目经费使用“包干制”改革试点；2021 年，国务院办公厅印发《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》（国办发〔2021〕32 号），明确提出扩大经费管理自主权、提高间接费用比例、推行经费包干的放权框架^[1]；2025 年，财政部和科技部进一步出台《国家重点研发计划资金管理办法》（财教〔2025〕2 号），为包干制提供了可操作的制度模板^[2]。与此同时，公立医院作为科研经费的重要承担主体，其内部控制建设亦同步深化。2023 年 12 月，财政部、国家卫生健康委等四部门联合印发《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31 号），明确要求“优化完善科研项目管理制度，确保科研自主权接得住、管得好”^[3]，《关于 2024—2025 年持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》进一步强调以业财融合为核心、以风险防控为重点的运营管理^[4]。

在公立医院科研经费场景中，政策放权与内部控制要求同时存在。既有研究已从绩效预算、全生命周期风险识别、政策推进困境和扎根理论等角度作出讨论^[5-8]，但较少把放权后的医院内控承接问题作为主线展开。本文以 24 份政策文件、理论框架与学术文献为综述基础，将其中 15 篇与医院管理实践直接相关的中文学术文献纳入“全生命周期 × COSO 五要素”双维矩阵编码，梳理共识、分歧和研究空白，重点讨论公立医院在科研经费包干制下如何重新划定控制边界。

2 文献来源与梳理方法

本综述采用范围综述取向，适用于既有研究主题分散、需要识别研究共识与空白的情境。资料来源分三部分。一是国家与行业层面与科研经费管理、公立医院内部控制相关的政策

法规 6 份[1-4,9,10]，以及国际内控理论母版 COSO《内部控制—整体框架》（2013 版）[11]；二是 2019—2026 年间发表于《卫生经济研究》《中国医院管理》《现代医院》《科技管理研究》《科技进步与对策》《会计师》等期刊的相关学术论文 15 篇[5-8,12-22]；三是补入 2 份国际资料作为跨文化参照，即 Hicks 关于 14 国绩效型科研资助体系的比较综述[23]与欧盟 ERC 2024 年 Lump Sum Grants 试点制度文件[24]。检索数据库为 CNKI 学术期刊总库（中文文献）与 Web of Science Core Collection（国际文献）。CNKI 主题检索式样例为：“（科研经费 AND 包干制）OR（科研经费 AND 内部控制 AND 公立医院）”，时间限定为 2019 年 1 月至 2026 年 5 月；本次复核中，CNKI 学术期刊总库在上述时间窗内识别候选题录 263 条。国际数据库以“lump-sum”AND “research funding”、“internal control”AND “public hospital”等主题词组合检索，Web of Science Core Collection 识别候选题录 1 条。该条聚焦公立医院供应链内部控制，与科研经费包干制议题关联度低，未纳入后续分析。中文文献以主题相关性、医院管理场景关联度和证据支撑强度为主要纳入标准，优先纳入医院管理、卫生经济、科研管理与内部控制相关研究，检索时间为 2026 年 5 月。24 份资料的类型、年份、来源与分析用途见表 1。

文献筛选参照 PRISMA-ScR 的流程逻辑，分为识别、题录筛选、全文评估与纳入四个环节：第一步，按上述数据库、时间窗与主题词组合识别候选资料；第二步，在题录层面按主题相关性初筛，剔除明显偏离的条目（包括纯财务会计制度讨论、未涉及公立医院或科研经费场景的内控文献、一般性政策评述等）；第三步，对题录入选文献进行全文研读，进一步剔除观点重复、证据支撑薄弱、与本综述核心议题（包干制落地与内控重构）相关度低的条目；第四步，最终保留 24 份分析资料，包括 6 份国内政策法规、1 部国际内控理论框架、15 篇中文学术论文、1 篇国际综述与 1 份国际制度文件。其中 COSO 理论母版、行政事业单位内控规范等核心文本作为制度与理论依据，不受 2019—2026 年时间窗限制。

上述 24 份资料用于全文综述、政策脉络梳理与制度参照；其中，表 2 的双维矩阵仅纳入 15 篇与医院科研经费管理实践直接相关的中文学术文献[5-8,12-22]，政策法规、COSO 理论母版和国际参照资料不作矩阵编码，以避免制度依据与经验研究混同。按以下三类组织资料：政策法规与制度文件簇作为分析的制度依据，理论框架簇作为内控分析的理论站位，实证与对策簇作为讨论主体。在此基础上，以“申报→立项→执行→结题→成果转化”五阶段为横轴、以 COSO 五要素（控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控）为纵轴构建双维矩阵，识别研究密点与疏点。

表 1 纳入分析资料基本情况表

编号	类型/年份	来源或发布主体	主题及分析用途	纳入理由
[1]	政策法规/2021	国务院办公厅	科研经费管理放权改革；用于说明包干制政策起点与放权框架	国家层面科研经费改革依据
[2]	政策法规/2025	财政部、科技部	国家重点研发计划资金管理；用于提炼包干制、内部管理规定与禁止性行为	包干制制度模板和负面清单依据
[3]	政策法规/2023	财政部等四部门	公立医院内部控制建设；用于说明科研自主权“接得住、管得好”要求	医院内控与科研管理衔接依据
[4]	行业政策/2024	国家卫生健康委、国家中医药局	公立医疗机构经济管理年；用于说明业财融合、风险防控和信息平台建设	医院运营管理与信息化嵌入依据
[5]	学术文献/2022	《卫生经济研究》	绩效预算与包干制管理；用于讨论放控并行和绩效预算约束	公立医院包干制管理研究
[6]	学术文献/2023	《现代医院》	科研项目全生命周期内控；用于风险环节分布和矩阵编码	全生命周期风险识别依据
[7]	学术文献/2024	《科技管理研究》	包干制政策推进特点与困境；用于政策执行和负面清单讨论	包干制政策推进研究
[8]	学术文献/2025	《科技进步与对策》	包干制实行影响因素；用于目标群体认知、执行意愿和控制环境分析	同一研究脉络的实证补充
[9]	内控规范/2012	财政部	行政事业单位内部控制规范；用于说明单位层面与业务层面控制结构	国内内控规范基础

编号	类型/年份	来源或发布主体	主题及分析用途	纳入理由
[10]	内控指导/2015	财政部	全面推进行政事业单位内控建设；用于分级授权和岗位制衡分析	授权控制设计依据
[11]	理论框架/2013	COSO	内部控制五要素；用于构建“全生命周期×COSO 五要素”分析框架	国际内控理论母版
[12]	学术文献/2023	《会计师》	科研经费精细化管理；用于责任边界和执行阶段控制环境分析	医院科研经费管理对策文献
[13]	学术文献/2024	《现代医院》	新时代公立医院科研管理制度逻辑；用于申报阶段和成果转化环节分析	医院科研管理制度逻辑研究
[14]	学术文献/2024	《中国医疗设备》	智慧财务在科研经费管理中的应用；用于信息化嵌入和量化效果分析	实践应用与量化证据
[15]	学术文献/2025	《新会计》	科研经费精细化管理；用于审计风险、结题管理和成果转化问题分析	审计与精细化管理依据
[16]	学术文献/2019	《经济师》	COSO 框架更新及启示；用于连接国内研究与 COSO 五要素	理论框架中文解读
[17]	学术文献/2022	《中国医院管理》	科研项目全过程管理体系建设；用于立项、执行、结题闭环分析	全过程管理实践文献
[18]	学术文献/2025	《卫生经济研究》	全面预算管理与内控框架；用于预算控制和结题阶段控制活动分析	预算内控框架文献
[19]	学术文献/2026	《现代医院》	预算管理内控理论与实践路径；用于绩效考核与内控耦合分析	预算内控与绩效衔接文献
[20]	学术文献/2025	《现代医院》	采购业务内控风险管理；用于立项论证和采购风险控制分析	采购环节内控参照
[21]	学术文献/2025	《中国医院管理》	收支内控信息化建设关键问题；用于信息沟通与系统嵌入分析	信息化内控研究
[22]	学术文献/2025	《中国医院管理》	智慧运营管理体系建设；用于业财融合和 HRP 系统路径分析	智慧运营与业财融合参照

编号	类型/年份	来源或发布主体	主题及分析用途	纳入理由
[23]	国际综述/2012	Research Policy	绩效型科研资助体系比较；用于说明放权效果依赖承担单位治理能力	国际绩效资助参照
[24]	国际制度/2024	European Research Council	Lump Sum Grants 试点；用于比较整额拨付与中国包干制的制度差异	国际制度参照

注：表中编号与文末参考文献编号一致。政策法规、内控规范和理论框架主要用于制度依据与分析框架建构；15 篇中文学术文献进入表 2 的双维矩阵编码；国际资料用于比较参照，不直接替代中国公立医院场景证据。

资料范围方面，本文在既有检索基础上补充列示 24 份资料的类型、来源和用途，并将资料边界限定为公开政策法规、内控理论框架、已发表学术文献和可核查国际制度资料。未公开的院内制度文本、个案材料和未能核实的检索结果未纳入分析，以避免把无法复核的材料写入综述结论；这一处理使资料范围、证据强度和研究边界在正文中保持一致。

本综述以 COSO《内部控制—整体框架》^[1]为国际理论母版，实证文献以国内中文期刊为主。这与“科研经费包干制”作为中国本土政策实践的属性相符：国际文献虽较少直接讨论中国语境下的包干制，但在绩效型科研资助^[23]、Lump Sum Grants 试点^[24]等议题上可提供参照。

3 政策演进脉络

公立医院科研经费包干制嵌入在科研经费放权改革与公立医院内部控制建设两条主线交汇之处。梳理近 15 年来的政策演进可见，这两条主线呈现“先各自深化、后双向衔接”的脉络，但在医院科研经费场景的对接上仍有明显空白。

3.1 中央放权框架的确立

科研经费放权改革始于“扩权松绑”的总体导向。国办发〔2021〕32 号文件明确提出“推行经费包干制、不再编制项目预算”，并配套“全面落实科研财务助理制度”与“项目承担单位履行法人主体责任”两项要求，奠定了“放权不放任”的基调^[1]。这一原则在 2025 年财教〔2025〕2 号中得到具体化：第三十条规定包干制项目“无需履行调剂程序”，同时要求承担单位“制定内部管理规定”；第三十

九条列出 10 类禁止性行为，事实上构成了可参照的“负面清单”蓝本^[2]。然而，这一最具操作性的制度模板仅限于国家重点研发计划专项口径，地方与院级层面的对应规则仍需要进一步细化承接。

3.2 内控规范与公立医院场景的专门化

内部控制规范也在同一时期推进。财会〔2012〕21 号《行政事业单位内部控制规范（试行）》提出“单位层面+业务层面”双层控制结构，财会〔2015〕24 号进一步提出“分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗”，COSO《内部控制——整体框架》2013 版则为本文提供五要素分析框架^[9-11]。在公立医院场景中，2020 年国卫财务发〔2020〕30 号、31 号文件形成医院内控制度框架；2023 年财会〔2023〕31 号第 18 条明确提出科研自主权要“接得住、管得好”；2024 年国卫财务函

〔2024〕132 号又把业财融合、运营管理信息集成平台和内控流程嵌入信息系统列为重点^[3,4]。这些文件共同说明，包干制不是放权后停止控制，而是要求医院把控制点转到授权、流程和信息系统。

国际资料可作为参照，但不能直接替代中国公立医院场景。欧盟 ERC 2024 年 Lump Sum Grants 试点采用项目层“整额拨付+不再逐项审核具体票据”的设计，更接近事后核销式改革；Hicks 对 14 国绩效型科研资助体系的比较综述也提示，放权效果依赖承担单位的内部治理能力^[23,24]。与此不同，财教〔2025〕2 号第三十条在放权同时要求承担单位“制定内部管理规定”^[2]。这一差异说明，本文需要关注的不是包干制是否放权，而是医院如何用院内规则承接放权。

综上，政策层面已经把科研经费放权与公立医院内控建设放在同一场景中，但医院层面如何承接放权、哪些事项可以授权、哪些风险必须前置控制，仍主要停留在原则表述。后文的文献综述即围绕这一落差展开。

4 内控视角下的研究图谱

为呈现既有研究的关注分布，本文以“申报→立项→执行→结题→成果转化”五阶段为横轴，以 COSO 五要素（控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控）为纵轴建立双维矩阵，将 15 篇与医院科研经费管理实践直接相关的中文学术文献归入相应交叉格，结果见表 2。横轴对应科研经费全生命周期，纵轴对应内部控制要素；每个交叉格表示该环节中某一控制要素受到的研究关注。该分类方式既借鉴行政事业单位内控规范对业务风险的划分，也与 COSO 2013 版关于目标和控制活动相互对应的要求相衔接[9,11,16]。

为保证编码可重复性，本文对每篇文献采用“主格+跨格”两层标记：主格指文献全篇主要论述的环节×要素交叉点，按摘要主题与高频段落判定；跨格指虽非主线但具有独立段落论述的次要交叉点；仅零散提及而无独立段落支撑的不计入。编码由第一作者完成初始判定，第二作者随机抽取 30% 条目复核；存在分歧时回到原文段落证据从严判定。文献^[7]与文献^[8]同属科研经费包干制政策推进研究脉络，在判断证据独立性时作为同一研究脉络看待，但矩阵编码仍按其具体论述内容分别标注。

表 2 公立医院科研经费包干制研究文献的双维矩阵分布

COSO 要素 ＼ 阶段	申报	立项	执行	结题	成果转化
控制环境	13, 7, 8	7	5, 12, 8	—	13
风险评估	—	6, 15	6, 14, 15, 8	15, 17	—
控制活动	15, 17	15, 17, 20	5, 12, 14, 15, 17, 18, 20	14, 17, 18	—
信息与沟通	—	—	6, 14, 21, 22	—	—
监控	—	—	14, 19	15, 17, 19	15

注：数字为本文参考文献编号；表 2 仅纳入中文学术文献[5-8,12-22]，政策法规、理论母版与国际参照资料不进入矩阵编码；同一文献在矩阵中出现多次表示其内容按上述“主格+跨格”原则覆盖多个环节或要素；文献[7]与文献[8]为同一研究脉络的两阶段成果。

需指出，文献^[6]同样给出过一张科研项目全生命周期管理表，但其以“流程—风险点—风险等级—内控措施”为列、属业务流程层的实务清单；本节矩阵以 COSO 五要素与项目阶段为正交两轴、目的在识别研究在元分析维度的密点与疏点——两者互为补充而非替代。

4.1 申报阶段：研究稀疏，集中于价值观与制度认知

申报阶段的研究多从控制环境切入，关注科研人员和管理者对包干制的理解与接受。吴佳怡等指出，科研管理中存在“政府逻辑与市场逻辑”的张力，权力与责任失衡是制度性根源；李昕彦等发现，“鼓励”“建议”等表述容易使基层执行者趋于保守；赵立雨和葛蕊的扎根理论研究也显示，政策内涵界定模糊、目标群体政策获得感不足，会影响申报阶段的执行意愿[7,8,13]。风险评估方面，张萍等基于 232 份有效问卷指出，申报环节风险占 27.72%，说明前端并非低风险环节[6]。罗淑颖等提出对申报书和预算合规性进行院内前置审查；庄健春则从审计角度指出，“不相容岗位未分离”在申报和立项环节即可能埋下隐患[15,17]。总体看，申报阶段已有风险提示，但信息与沟通、监控等要素几乎没有文献覆盖，前端干预仍是薄弱处。

4.2 立项阶段：控制活动主导，风险评估初现

立项阶段的研究以控制活动为主线。罗淑颖等设计的“任务书+预算合规性审查”流程是典型做法；钟嘉慧等从采购视角提炼出立项论证“缺标准、缺资料、流于形式”三类风险，并提出“统一立项申请书模板+集体研究决策”对策；庄健春的审计

实证补充了立项不规范导致经费使用不合规的链条^[15,17,20]。在风险评估维度，张萍等的 232 份问卷数据显示立项环节风险占 20.79%，主要表现为合同指标虚高与预算录入出错^[6]。然而，立项阶段在信息与沟通、监控两个要素上仍呈空白，部门协同机制与立项后追踪机制是潜在的研究增量空间。

4.3 执行阶段：研究密点，五要素全覆盖

执行阶段是全矩阵研究密度最高的区域，五要素均有文献覆盖。

在控制环境维度，綦学铭、邱英等与赵立雨、葛蕊分别从经费管理责任、绩效预算约束和政策获得感角度提示：执行阶段的内控并不只是报销审核，还取决于项目负责人、科研管理部门和财务部门之间的责任边界是否清楚^[5,8,12]。因此，医院需要先说明项目负责人承担哪些责任、科研财务助理提供哪些支持、负面清单如何解释；如果这些规则不清，后续控制活动容易退回逐项审批。

在风险评估维度，张萍等基于 232 份有效问卷给出了风险环节分布的实证证据——其中执行环节风险占比 46.53%，高于申报（27.72%）与立项（20.79%）；原文该项统计仅覆盖申报、立项、执行三个“业务管理流程”环节，结题与成果转化环节的风险通过案例与表格分析单独讨论而未给出对应占比^[6]。时玉梅等、庄健春、赵立雨和葛蕊则分别从结余挂账、审计风险与管理者避责心理等角度具体化了执行阶段的风险表现^[8,14,15]。

在控制活动维度，既有研究围绕权责清单、预算弹性管理、科研财务助理、采购合同控制、预算执行控制和资产台账管理等提出了较为丰富的对策^[5,12,14,15,17,18,20]。这一阶段因直接对应报销、采购、合同、资产和预算执行等高频业务，成为矩阵中研究最密集的区域。

信息与沟通维度的证据主要来自信息化实践。时玉梅等记录了智慧财务系统上线前后的变化：单据报销时长缩短 9.25 天，退单率下降 73.60%，科研人员满意

度由 30%升至 85% ($P<0.05$) [14]。这组数据说明, 信息系统并非只改变报销形式, 而是会影响材料提交、退单反馈和科研人员体验。李梦斐等、王乐等关于信息化关键问题和 HRP 系统的研究, 则进一步把这一问题延伸到业财融合和跨部门数据衔接[21,22]。

监控维度的讨论相对集中, 主要涉及审计前移、过程跟踪和事后评价之间的衔接[14,19]。这些研究提示, 包干制下的监督不宜只等到结题或报销后才启动, 部分风险需要在合同、采购、资产入账和预算执行过程中留下可复核记录。

总体看, 执行阶段之所以形成研究密点, 是因为它直接对应报销、采购、合同、资产和预算执行等高频业务。已有文献已经反复指出这些风险, 后续研究更需要回答工具是否有效, 例如负面清单能否减少争议事项, 系统校验能否降低退单, 科研财务助理能否缩短办理时间。

4.4 结题阶段：控制活动与监控并重，风险识别细化

结题阶段的研究以控制活动与监控并重。在控制活动维度, 既有研究强调决算审查合规性、“技术完成度+经费合规性”双重验收、必要时第三方审计, 以及通过预决算差异率与支出结构占比优化后续资源配置[14,17,18]。在监控维度, 相关研究从内审渗透、绩效考核与下年度经费分配挂钩、预算执行结果纳入科室和人员绩效等方面提出闭环思路[15,17,19]。在风险评估维度, 结题阶段的风险识别主要围绕“结题不规范”与“验收形式化”展开[15,17]。

4.5 成果转化阶段：研究最稀疏，仅触及问题陈述

成果转化是矩阵中最稀疏的环节, 仅 2 篇文献涉及: 吴佳怡等提出“伦理化与市场化相结合”原则, 庄健春指出“成果转化不明显”是公立医院科研管理的突出问

题之一[13,15]。这说明现有研究更多关注经费使用过程，对结题以后成果如何评估、收益如何分配、风险如何控制讨论不足。

4.6 矩阵分析小结

综合表 2，现有研究呈现“两端薄弱、中间集中”的分布特征：密点集中在执行阶段——“执行 × 控制活动”格 7 篇、“执行 × 信息与沟通”格 5 篇、“执行 × 风险评估”格 4 篇，是研究主战场；疏点则在两端——申报阶段五要素中三个（风险评估、信息与沟通、监控）无文献覆盖，成果转化整列仅 2 篇文献零星涉及且缺少具体控制设计。可见，既有研究较擅长回答“执行中如何管”，但对“前端如何预防”和“后端如何转化”关注不足。

5 共识与分歧

5.1 文献中较稳定的判断

从纳入文献看，包干制研究首先呈现出“政策推进较快、院内承接较慢”的特征。綦学铭、邱英等关注理论落实和绩效预算，李昕彦等从政策文本梳理推进困境，赵立雨和葛蕊则从目标群体感知解释执行保守的原因[5,7,8,12]。这些研究指向同一问题：制度层面的放权已经明确，但医院内部的责任边界、操作口径和风险承接规则仍需细化。

风险分布也较为集中。第 4.3 节已经显示，执行环节在问卷统计、审计案例和信息化实践中反复出现，涉及经费支出、采购合同、资产入账、结余挂账和结题不结账等问题[6,14,15]。因此，包干制下的内控重点不能只放在项目获批前，也要覆盖经费实际使用过程。

关于治理取向，文献并未把包干制理解为简单放松管理，而是反复强调放权后仍要有边界。相关研究提出的绩效结果导向、评价约束、负面清单和全过程管

理，虽然表述不同，但共同关注“哪些事项可以自主、哪些事项必须受控”这一问题[5,7,17]。

信息化嵌入是另一个反复出现的方向。智慧财务系统上线前后的量化对照、信息化建设关键问题识别和 HRP 系统案例均提示，系统规则可以把预算额度、经费类别、合同节点和报销材料前置到办理流程中[14,21,22]。这类研究的价值不在于强调“上系统”，而在于说明内控规则如何进入日常操作。

负面清单则提供了较具体的制度接口。财教〔2025〕2号第三十九条列出10类禁止性行为，李昕彦等和赵立雨、葛蕊也都注意到负面清单在基层执行中的作用及其不清晰带来的问题[2,7,8]。对公立医院而言，关键不是重复列出原则，而是把禁止性行为转译成科研经费报销、采购、外拨、资产和成果转化等场景中的可识别事项。

需要说明的是，文献[7]与文献[8]属于同一研究脉络的两个阶段成果，赵立雨为两篇共同作者。本文并列引用二者，是因为前者侧重政策文本梳理，后者补充扎根理论实证；在判断证据独立性时，二者仍按同一研究脉络理解。

5.2 尚未解决的操作分歧

第一类分歧在于全过程管理与包干制放权之间如何协调。罗淑颖等针对“重立项、轻结题”提出全过程动态管理和中期考核，庄健春也主张加强过程监管[15,17]；但包干制政策同时强调减少过多干预、无需履行调剂程序[2]。如果过程管理仍沿用逐项审批逻辑，就可能抵消包干制的弹性；如果完全弱化过程控制，又难以回应审计和合规风险。现有文献尚未给出二者衔接的操作边界。

第二类问题是纵向经费和横向经费是否应采用同一套规则。邱英等提出纵向科研经费纳入财政资金绩效监管时应避免“一刀切”，綦学铭也指出科研经费并非由

科研部门单独管理，容易形成多头分歧[5,12]。不过，多数文献并未展开区分讨论，因此这里与其说是明确观点对立，不如说是场景拆分不足。

第三类分歧集中在分级授权的尺度。财会〔2015〕24号提出授权范围、对象、期限、责任以及一般授权和特殊授权界限，时玉梅等提到扩大项目负责人直接审批权限，罗淑颖等也设计了“四级报账程序”[10,14,17]。这些讨论说明授权分层已有制度基础，但仍缺少“金额×事项×岗位”的具体表单，实际执行时仍要靠各医院自行解释。

第四类问题是绩效考核与内控指标如何衔接。现有文献普遍认可绩效约束的重要性，但较少说明哪些控制活动可以转化为绩效扣分项，哪些风险事件需要触发再评价，哪些事项只应提醒补正而不宜直接惩罚[5,13,17,19]。这使绩效约束容易停留在原则层面。

5.3 共识—分歧小结

因此，第5节得到的结论可以概括为两层：一是已有文献对风险位置和治理方向已有较多共识，尤其是执行环节风险、放控并行、负面清单和信息化嵌入；二是这些共识尚未充分转化为医院可直接使用的表单、阈值和流程规则。后续研究若要推进包干制落地，重点应放在工具层面的细化，而不是继续重复一般原则。

6 研究空白

前文梳理显示，现有研究已经说明包干制为什么需要内控承接，但对“医院具体怎么做”的回答仍不充分，主要体现在以下四个方面。

空白一是医院级方案仍不完整。已有研究有的侧重政策解读，有的集中于单一案例，有的只讨论某一业务环节[6-8,14,17]。这些成果各有价值，但尚未把政策

要求、COSO 内控框架和医院科研经费流程放在同一分析链条中，因而难以直接形成院级落地方案。

空白二是负面清单和分级授权还缺少细目。第 5 节已指出，分级授权多停留在原则层面[10]，负面清单也主要来自财教〔2025〕2 号列出的 10 类禁止行为[2]。对于医院来说，还需要进一步回答哪些金额区间由项目负责人决定，哪些采购、外拨、资产和成果转化事项需要科研、财务或审计共同审核。

空白三：科研、管理、财务三类岗位认知差异的实证测量缺失。既有研究已注意到群体认知差异、目标群体政策认知和统一样本问卷的局限[6-8]，但尚未按科研、管理、财务三类岗位分卷设计。三类岗位的认知分化既影响政策传导效果，也影响内控设计的针对性。

空白四：小群体证据链方法仍待补充。既有研究已有大样本问卷和单院上线前后量化对照两种做法[6,14]。但在公立医院科研管理、财务、审计等岗位人数有限的场景中，如何用“近普查口径+访谈+专家咨询法（Delphi）”交叉验证风险点，现有文献讨论较少。

7 对医院管理实践的启示

从纳入资料看，包干制在医院落地时，问题并不只出现在报销审核环节，而是贯穿预算编制、采购合同、经费支出、资产入账、结题结账和成果转化等日常流程。因此，医院推进包干制时，不能只删减审批节点，还要同步说明哪些事项由项目负责人自主决定，哪些事项仍需科研、财务或审计部门参与，哪些材料必须在系统中留痕。

7.1 将“少审批”转化为“边界清晰”

包干制放宽预算调剂和逐项审核后，医院首先要回答的不是“还要不要管”，而是“哪些边界必须提前说清”。建议围绕人员费、耗材采购、测试化验、差旅会议、协作外拨、资产入账、结余资金和成果转化收益等高频事项，分别列出禁止事项、限

制事项、可自主事项和需说明理由事项。这样既能保护科研人员合理自主权，也能避免财务审核在事后重新变成逐项否决。

7.2 以“负面清单+分级授权”固化院级规则

院级制度不能只写“分级授权”，还需要形成“事项类型×金额区间×责任岗位”的授权表。一般性、低风险事项可交由项目负责人自主决定；金额较高、外拨协作、形成资产、预算用途发生实质变化等事项，应设置科研管理、财务和审计审核节点；例外情形则明确进入特殊授权或集体决策程序。这样才能把财会〔2015〕24号提出的分级授权要求[10]落到科研经费办理表单中。

7.3 把内控规则嵌入科研经费信息系统

信息化建设不宜停留在电子报销。医院可把预算额度、经费类别、合同节点、采购流程、资产入账、结题结账和留痕材料写入系统校验规则：明显超出边界的事项在提交前提示，接近阈值或材料不完整的事项在办理中预警，结题、成果转化和结余资金处理则保留可追溯记录。这样，内控不再主要依赖经办人员经验，而是进入日常办理流程[3,21]。

7.4 以服务型内控降低科研人员制度摩擦

包干制能否落地，也取决于科研人员是否愿意按规则使用制度。医院可通过科研财务助理、常见问题库、分角色培训、示例化报销清单和容错纠错流程，把复杂制度翻译成科研人员能看懂、能操作、能询问的办理指引。对首次发生、非主观故意且未造成资金损失的轻微偏差，可设置提醒、补正和复盘；对触碰负面清单或存在利益冲突的事项，则保持刚性约束。

8 结论与展望

本文以 24 份政策文件、理论框架与学术文献为综述基础，其中 15 篇中文学术文献纳入“全生命周期×COSO 五要素”双维矩阵编码，梳理公立医院科研经费包干制研究。研究发现：既有文献主要集中在执行环节、控制活动和信息化嵌入，对申报前端干预和成果转化后端控制关注不足；学界已在落地难、执行风险高、放控并行、信息化嵌入和负面清单管理方面形成共识，但在过程管理兼容性、纵横经费区分、分级授权阈值、绩效与内控耦合方面仍缺乏操作方案。

综上，公立医院科研经费包干制的关键不是在“放”与“控”之间二选一，而是在放权后重新设计内部控制。具体到医院流程，包干制压缩前置审批、减少预算调剂程序后，传统

“阻断式”控制需要转向边界清楚、过程可见、责任可追溯的控制方式；负面清单、分级授权和嵌入式系统分别回答“哪些事项不能做”“谁可以决定什么”“规则如何进入日常办理流程”。

从 COSO 框架看，这一转变意味着控制重心发生前移。包干制压缩前置审批后，传统“逐项审核+刚性阻断”的空间变小；“接得住、管得好”则要求医院先用负面清单和分级授权说明合规边界，再用信息系统和科研财务助理提供过程支持。因此，控制环境、信息与沟通的重要性上升，控制活动也需要从逐项审核转为边界设置和规则嵌入。

本研究主要依据公开政策、理论框架和已发表文献，未纳入未公开院内制度文本和个案材料，因此对不同医院流程差异的解释仍有限。后续研究可从四个方面推进：一是用单院数据验证风险点并形成院级清单；二是检验内控规则如何嵌入医院信息系统[3,21]；三是分析业财融合、人工智能对预算控制和风险预警的影响[19,22]；四是结合欧盟 ERC Lump Sum Grants 试点和绩效型科研资助体系研究[23,24]，比较不同制度下放权与控制的衔接方式。

参考文献

- [1] 国务院办公厅。国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见：国办发〔2021〕32号[R/OL]. 2021. <https://app.www.gov.cn/govdata/gov/202108/13/474682/article.html>.
- [2] 财政部，科技部。国家重点研发计划资金管理办法：财教〔2025〕2号[R/OL]. 2025. https://fgk.mof.gov.cn/ui/src/views/law_html/1907279959500537857.html.
- [3] 财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局关于印发《关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见》的通知[J]. 中华人民共和国财政部文告, 2023(12): 4-13.
- [4] 国家卫生健康委，国家中医药局。关于2024—2025年持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知：国卫财务函〔2024〕132号[R/OL]. 2024. <https://www.nhc.gov.cn/caiwusi/c100042/202407/dd4f60b217fd4418a8a824cd79c79647.shtml>.
- [5] 邱英, 林媛, 金晓敏. 基于绩效预算的公立医院科研经费“包干制”管理[J/OL]. 卫生经济研究, 2022, 39(1): 87-89. DOI:10.14055/j.cnki.33-1056/f.2022.01.024.
- [6] 张萍, 黎心榆, 胡美晨, 等. 基于内部控制视角的医院科研项目全生命周期管理的探讨与分析[J]. 现代医院, 2023, 23(8): 1269-1272.
- [7] 李昕彦, 占庆梦, 赵立雨. 科研经费“包干制”政策的推进特点、实施困境与优化路径[J]. 科技管理研究, 2024, 44(17): 30-37.
- [8] 赵立雨, 葛蕊. 基于扎根理论的科研经费“包干制”实行影响因素与政策启示[J]. 科技进步与对策, 2025, 42(2): 22-30.
- [9] 财政部印发行政事业单位内部控制规范[J]. 国际商务财会, 2012(12): 81.
- [10] 财政部。关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见：财会〔2015〕24号[R/OL]. 2015. https://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/hjs/201601/t20160107_2512727.htm.
- [11] COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION. Internal Control—Integrated Framework[R]. Durham, NC: COSO, 2013.
- [12] 綦学铭. 新形势下公立医院科研经费精细化管理探究[J]. 会计师, 2023(2): 134-136.
- [13] 吴佳怡, 林贤珊, 陈婉霞, 等. 新时代公立医院科研管理的制度逻辑：内涵、原则与路径[J]. 现代医院, 2024, 24(11): 1655-1657.
- [14] 时玉梅, 徐迅, 杨光, 等. 基于智慧财务的公立医院科研经费管理应用实践[J]. 中国医疗设备, 2024, 39(2): 101-107.
- [15] 庄健春. 公立医院科研经费精细化管理探究[J]. 新会计, 2025(10): 65-70.
- [16] 史姝玥. COSO委员会的内部控制整合框架更新及启示[J]. 经济师, 2019(1): 116-

- [17] 罗淑颖, 黄河湍, 张耀东, 等. 新形势下医院科研项目全过程管理体系建设实践探讨[J]. 中国医院管理, 2022, 42(7): 59-61.
- [18] 胡玮楠, 陈韵西. 公立医院全面预算管理及其内部控制框架搭建[J/OL]. 卫生经济研究, 2025, 42(8): 87-90. DOI:10.14055/j.cnki.33-1056/f.2025.08.011.
- [19] 何莹. 内部控制视角下强化医院预算管理的理论分析与实践路径[J]. 现代医院, 2026, 26(03): 454-457.
- [20] 钟嘉慧, 李舒慧, 杨文怡, 等. 公立医院采购业务内部控制风险管理研究[J]. 现代医院, 2025, 25(1): 108-110.
- [21] 李梦斐, 陈仪蓉, 潘悦华, 等. 基于内容分析法的公立医院收支内部控制信息化建设关键问题研究[J]. 中国医院管理, 2025, 45(12): 85-89.
- [22] 王乐, 沈柳菁, 丁小英, 等. 基于业财融合的公立医院智慧运营管理体系建设路径探索[J]. 中国医院管理, 2025, 45(4): 78-81.
- [23] HICKS D. Performance-based university research funding systems[J/OL]. Research Policy, 2012, 41(2): 251-261. DOI:10.1016/j.respol.2011.09.007.
- [24] EUROPEAN RESEARCH COUNCIL. Lump sums in Advanced Grants 2024[EB/OL]. 2024. <https://erc.europa.eu/news-events/news/lump-sums-advanced-grants-2024>.